成人呼吸道評估與處理

亞急性呼吸照護病房

呼吸道是空氣進出肺部的通道，透過呼吸的過程使人體獲得足夠氧氣，排出體內的二氧化碳，若呼吸通道受傷、發炎或塞住，可能影響正常呼吸，危及生命。

一、 呼吸道構造

呼吸道分為上呼吸道及下呼吸道。上呼吸道：鼻及喉；下呼吸道：氣管及肺。

二、正常及異常呼吸的評估

(一) 正常呼吸：成人正常呼吸次數約每分鐘 12-20 次，呼吸的時候沒有聲音、不費力。

(二) 異常呼吸：若呼吸次數每分鐘 30 次以上，呼吸的時候出現隆隆聲，感覺喘不過氣或呼吸很用力，就是呼吸異常。最常見的原因是痰多、痰稠或咳不出來。

三、 導致異常呼吸的原因

(一) 呼吸道阻塞（最常見的原因）。

(二) 痰液咳不出來。

(三) 痰變多、變稠。

(四) 吸入異物(如：喝水嗆到或吃東西噎住)。

四、維持呼吸道通暢的方法

(一) 鼓勵病人每天喝水 1500-2000 毫升，可稀釋痰液，讓痰容易咳出。若病人有心、腎相關疾病，建議喝水量約 1000-1500 毫升或依醫師指示補充喝水的量。

(二) 三餐飯前 1 小時及睡前執行拍背，使痰液鬆動幫助痰液咳出。

(三) 做緩慢的深呼吸，吸氣至無法吸氣後憋氣，再使用腹部的力量咳嗽，將痰咳出，若無法將痰咳出，可使用抽痰機將痰抽出。

(四) 將床頭抬高，避免舌頭後倒，保持坐臥姿。

五、注意事項

痰液清除後，病人喘不過氣或呼吸用力的情形未改善，則盡快聯絡醫療人員或 119 送醫。

六、結論

當病人呼吸道阻塞情況排除，陪伴及輕柔的解釋非常重要。要先穩定自己及病人的情緒，不要讓害怕加重喘的症狀。接著評估病人是不是有哪裡不舒服，通常疼痛也會引起呼吸加快，造成病人呼吸喘。此時家人的支持與陪伴對病人相當重要，要鼓勵他、給他信心，必要時可以轉移病人的注意力，和他談談其他事情，不要讓病人專注在喘這件事上。

六、參考資料

王桂芸、馮容芬、李惠玲、周桂如、高啟雯、陳麗華、詹恩愉、歐嘉美（2023）. 呼吸系統疾病與護理. 於王桂芸、劉雪娥、馮容芬總校閱，*內外科護理學*（七版，1119-1120 頁）. 永大。

制定：2015/10；修訂、審閱：2025/11

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。
著作權人：高雄醫學大學附設中和紀念醫院